Resumos de Pediatria

Batistaz

Revisão Flash · Infectologia

Antibioticoterapia

Escolhas empíricas e doses nas infecções comuns

Internato de Pediatria

10º período · 2026.2

Antibioticoterapia em pediatria

Leitura de 5 minutos

Em uma frase

Decida se precisa, não atrase no grave, escolha pela síndrome e pela idade, calcule na unidade certa e reveja em 48–72 horas com a cultura.

1. **Tempo:** choque até 1 h; sepse provável até 3 h; meningite não espera líquor.
2. **Meningite > 2 m:** ceftriaxona 100 mg/kg/dia 12/12 h ou cefotaxima 200 6/6 h.
3. **Meningite < 2 m:** ampicilina + cefotaxima; nada de ceftriaxona no neonato.
4. **Profilaxia (≥ 1 mês):** meningococo rifampicina 10 mg/kg 12/12 h 2 d; Hib 20 mg/kg 1×/d 4 d; máx. 600 mg/dose. < 1 mês: metade.
5. **ITU:** saco coletor positivo se confirma; febril, VO > 3 m, 10 dias.
6. **ITU febril:** cefuroxima 30 mg/kg/dia VO; nunca nitrofurantoína.
7. **Pele leve:** cefalexina 25 mg/kg/dose 12/12 h; abscesso: drenar.
8. **Disenteria com estado geral comprometido, ≤ 30 kg, ≥ 3 m, sem imunodeficiência:** azitromicina 10 mg/kg D1 + 5 mg/kg D2–D5.

Vias aéreas

Quadro	Amoxicilina
OMA (AIDPI)	50 mg/kg/dia, 8 d
Faringite	50 mg/kg/dia, 10 d
Sinusite	25–50 mg/kg/dia, 7–10 d
PAC	50 mg/kg/dia, 7 d

Pegadinha

Vancomicina nunca sozinha na meningite pneumocócica resistente.

Checklist antes do plantão

- ☐ Sei quando não dar antibiótico
- ☐ Separo mg/kg/dia de mg/kg/dose
- ☐ Classifico a alergia
- ☐ Prescrevo meningite por idade
- ☐ Faço a profilaxia de contatos
- ☐ Colho urina do jeito certo
- ☐ Trato ITU febril por via oral
- ☐ Trato disenteria pelo cartaz
- ☐ Reviso em 48–72 h